

Un bambino nel vostro ambulatorio

Per medici di famiglia, infermieri e professionisti sanitari — nella cura di un **bambino autistico in età prescolare** (circa 2–5 anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un bambino viene richiamata in pochi „tunnel” profondi e intensi alla volta. Dentro un tunnel, il focus è vivido e ricco; fuori, le cose si registrano a malapena — a volte inclusi dolore, fame o qualcuno che parla. Cambiare tunnel costa energia reale (*inerzia autistica*). Questo spiega gli interessi intensi, le reazioni sensoriali, il bisogno di routine e i meltdown/shutdown. La cosa più utile che potete fare in ambulatorio è lavorare **con** il tunnel, non contro di esso.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Non fa contatto visivo; guarda altrove; sembra ignorarvi	Il contatto visivo e l'attenzione divisa costano risorse scarse; guardare altrove aiuta il bambino a regolarsi e ad ascoltare
Assorbito profondamente in un oggetto; allinea le cose; gioca „in modo diverso”	Gioco monotropico — valido e significativo, non „sbagliato”; spesso la via del bambino verso calma e apprendimento
Pianto improvviso, urla, si affloscia o tace	Un meltdown o uno shutdown involontario da luci, rumore, l'attesa o il dolore — <i>non</i> monelleria
Non dice dove prova dolore; non nota un urto o qualcosa di caldo	Quando è assorbito, dolore e segnali interni possono davvero non registrarsi
Risponde lentamente; ripete le vostre parole	Tempo di elaborazione + comunicazione a canale singolo, letterale

Provate questo

- **Leggete la famiglia per prima.** Offrite un breve modulo pre-visita (*l'Autism Healthcare Accommodations Tool* di AASPIRE, autismandhealth.org) su bisogni sensoriali, comunicativi e procedurali — e leggetelo prima che arrivino.
- **Prenotate lo slot più silenzioso** (il primo o l'ultimo), permettete un adulto di fiducia e accogliete il loro **kit sensoriale** (cuffie antirumore, occhiali da sole, un oggetto di conforto o di interesse).
- **Abbassate il carico:** luci più basse, silenziate i bip dove possibile, niente profumi forti.
- **Dite cosa accadrà, poi fatelo** — frasi brevi e letterali, un passo alla volta; mostrate prima lo strumento.
- **Lasciate che il bambino guardi altrove, stimmi e tenga l'oggetto di interesse** durante la visita. Entrate nel suo interesse per creare rapporto *prima* di visitarlo.

Evitate questo

- Forzare il contatto visivo, trattenere il bambino, o proporre una procedura a sorpresa.

- Istruzioni verbali lunghe o frasi come „sii coraggioso!” — dite esattamente cosa accadrà, e mantenetelo.
- Leggere pochi minuti calmi e mascherati come „sta bene” — un bambino piccolo può pagare la visita con uno shutdown dopo.

Quando serve altro supporto

Inviare precocemente per una valutazione dell'autismo se notate attenzione rallentata/„appiccicosa”, interessi focalizzati intensi, differenze sensoriali o gioco atipico — l'identificazione precoce aiuta le famiglie ad adattare l'ambiente, non il bambino. Guardatevi dal **burnout autistico** / „**regressione**” da sovraccarico: una perdita di abilità di solito significa *ridurre le richieste e ripristinare riposo e interessi*, non spingere di più. Prendete sempre **seriamente l'osservazione dei genitori**. Segnalate il consultore, i servizi pediatrici e il supporto locale ai genitori guidato da persone autistiche.

Se il bambino è una bambina

Le bambine spesso sono migliori nel **camuffamento** precoce e vengono individuate meno. Prendete sul serio l'osservazione dei genitori anche quando la presentazione sembra „sottile” o „sociabile” — lo sforzo mascherato in ambulatorio è sforzo reale.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la sintesi sul **Monotropismo** e la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parti 3.1 e 4). Usa il linguaggio con l'identità per prima („bambino autistico”). **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico.** Il **monotropismo** è una teoria potente ma ancora in sviluppo; adattatela sempre al singolo bambino.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2018/2023); Dwyer (2025); AASPIRE Healthcare Toolkit / AHAT (autismandhealth.org); Raymaker et al. (2020, burnout autistico); Kelly Mahler (2024, interocezione); Landry & Bryson (2004, sguardo appiccicoso). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.